血中ＴＡＲＣ測定における検体取り扱い条件の比較検討

◎下田 汐梨[1)]、鈴木 崇峰[1)]、藤巻 恵理子[1)]、高尾 晶子[1)]、塚本 実奈子[1)]、谷 浩也[1)]
愛知医科大学病院[1)]

【目的】TARC はアトピー性皮膚炎の有用なバイオマーカーである。血清中の TARC は血小板由来の成分が相当量含まれ、検体前処理における血小板活性化条件が測定値に影響すると推測される。今回、採血管種および検体取り扱い条件の違いによる TARC 測定値の変動比較を目的として検討したので報告する。【対象】健常被検者 3 名に、採血管 A（分離剤あり、凝固促進剤あり、トロンビンあり）、採血管 B（分離剤あり、凝固促進剤あり、トロンビンなし）、採血管 C（分離剤なし、凝固促進剤なし、トロンビンなし）で採血した。測定装置は HISCL-5000（Sysmex 社）を使用した。【方法】採血管 A・B・C の検体を用いて、①採血管種と遠心前静置時間（凝固確認後 0h・3h・6h 静置し、3500g・8 分で遠心分離）の比較、②血清保存条件（①の血清を各々-20℃・4℃で 24h・48h 保存後測定）の比較をした。【結果】①採血管 C は 0h 静置検体の値と比較し、3h・6h 静置検体の値に上昇傾向を認めた。一方、採血管 A は被験者 3 人のうち 1 名において 0h 静置検体の値と比較し、3h・6h 静置検体の値に低下傾向を認めた。また、採血管 B は被験者 3 人のうち 1 名において 0h 静置検体の値と比較し、3h・6h 静置検体の値に低下傾向を認めた。②-20℃保存条件下では、3h・6h 静置検体で 48h 保存後測定値に有意な低下を認めた（$p<0.05$）。4℃保存条件下では、3h 静置検体で 48h 保存後測定値に有意な低下を認めた（$p<0.05$）。【考察】方法①より、採血管 C では時間経過に伴う血小板活性化の持続により TARC 放出量が増加したため、全血放置時間が長いほど値が上昇したと考えられる。一方、採血管 A・B では凝固促進剤やトロンビンにより、血小板活性化およびそれに伴う TARC 放出量に差が生じたことで 0h 静置検体より値が低下したと考えられる。方法②より、TARC は低分子タンパク質であるケモカインの一種であり、全血放置や室温放置により分解・失活するため、値が低下した可能性がある。以上より、理想的な検体取り扱い方法は、分離剤、凝固促進剤等を含まない採血管を使用し、凝固確認後速やかに遠心分離した血清を測定することである。遠心後速やかに測定ができない場合には、-20℃または 4℃保存で 24h 以内に測定することが望ましい。連絡先 : 0561-62-3311